

Care for One Day Surgery (ODS) Patients

การพยาบาลผู้ป่วยนอกที่มารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

พว.วรลักษณ์ บุญชัย

ผู้ตรวจการพยาบาล

งานการพยาบาลผ่าตัด

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

28 สิงหาคม 2569 (11:00-12:00น.)

ประเทศไทย 4.0
ด้านสาธารณสุข
ระยะ 5 ปี
2560 - 2564



วิสัยทัศน์

: มุ่งสู่ Value-Based Health Care



กลไกหลัก 3 Engines

- 1. Inclusive Growth Engine :** กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โจทย์คือทำอย่างไรให้ประชากรทุกเพศทุกวัยได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขเท่ากัน เด็กไทยต้องได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์ แม่ ได้รับสารอาหารครบถ้วน มีพัฒนาการทั้งสติปัญญาและอารมณ์อย่างสมวัย ส่วนผู้สูงอายุ ต้องสร้างคุณค่าให้สังคมยอมรับ ไม่ใช่ถูกขังไว้ที่บ้าน ต้องมีงานทำหรือมีรายได้เลี้ยงตัว และต้องมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่ติดเตียง
- 2. Productivity Growth Engine :** กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยได้กำหนดสมุนไพร 4 ชนิด เพื่อส่งเสริม ได้แก่ ไพล กระจายดำ ขมิ้นชัน และใบบัวบก ซึ่งใบบัวบกใช้สกัดสารมาทำเครื่องสำอาง ส่วนกระจายดำช่วยให้ชีวิตยืนยาว และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น
- 3. Green Growth Engine :** กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจะมุ่งสร้าง **Green and Clean Hospital** เป็นสถานพยาบาลที่ไม่ปล่อยขยะติดเชื้อออกสู่ชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านบุคลากร ระบบ**HR** และการเงิน

กลไกหลัก 3 Engines

กระทรวงฯ ได้มีการขับเคลื่อน 3 กลไกนี้ ด้วย 10 ประเด็นหลัก
โดย **One Day Surgery & Minimal Invasive Surgery**
จะอยู่ใน **Inclusive Growth Engine** ประเด็นของเรื่อง **Service**
ตามแผนภาพ



กลไกการขับเคลื่อน 3 Engines 10 ประเด็นหลัก





ขอขวัญปีใหม่ 2561

จากใจ สร. 4.0



บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
(One Day Surgery)

★ แพ้ตึงแนวใหม่ วันเดียวกลับบ้านได้
ปลอดภัยไม่เสียเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย





Application RDU รู้เรื่องยา

★ สารเพิ่มความรู้เรื่องยาบนเครือข่ายดิจิทัล
★ ข้อมูลน่าเชื่อถือ เข้าถึงสะดวก ใช้งานได้ปลอดภัย



Application Samunprai First

★ ครบเครื่องเรื่องสมุนไพรไทยแปดปี เดียว
★ ใช้สมุนไพรรักษาอาการป่วยอย่างมั่นใจ
★ ค้นหาสถานที่จำหน่ายได้รวดเร็ว



1 มีคณะกรรมการดูแลโครงการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery ของโรงพยาบาล

2 มีศูนย์ประสานงานการบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery ของโรงพยาบาล

3 มีระบบติดตามผู้ป่วยก่อนและหลังการทำหัตถการ

4 มีแนวทางการปฏิบัติเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ก่อนการทำหัตถการ

5 มีแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย ของการทำหัตถการการผ่าตัด

6 มีแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยในระยะพักฟื้น

7 มีระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง

8 มีการจัดอัตรากำลังเพื่อรองรับโครงการ แพทย์: ผู้รับผิดชอบโครงการ (doctor manager) แพทย์สาขาที่เปิดบริการ วิทยุแพทย์ พยาบาล: พยาบาลที่รับผิดชอบ (nurse manager) พยาบาลที่กึ่งห้อง

9 มีการจัดสถานที่เพื่อรองรับโครงการ มีการจัดเตียงเฉพาะ ในหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยหลังการพักฟื้น หลังการผ่าตัด

ศักยภาพของหน่วยบริการ ที่จะให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
ที่กำหนดโดย คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery ๙

<http://118.174.45.29/hhc/THAI HealthCare System>

ผศ. นพ. รัชเดช นิมมานวุฒิพงษ์
ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
และประเมินผลการขึ้นทะเบียน



เขต 1 เชียงใหม่
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน
พะเยา แม่ฮ่องสอน
ลำปาง ลำพูน

เขต 2 พิษณุโลก
พิษณุโลก, ตาก, เพชรบูรณ์,
อุทัย, อุตรดิตถ์



เขต 8 อุดรธานี
อุดรธานี สกลนคร,
นครพนม, หนองคาย, เลย,
หนองบัวลำภู, บึงกาฬ



เขต 7 ขอนแก่น
ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด



เขต 10 อุบลราชธานี
อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร
ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ



เขต 9 นครราชสีมา
นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์



เขต 6 ระยอง
ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ตรัง ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก้ว



เขต 12 สงขลา
สงขลา ตรัง นราธิวาส
ปัตตานี พัทลุง ยะลา
สตูล



เขต 11 สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา ภูเก็ต ภูเก็ต



เขต 5 ราชบุรี
ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม
สุพรรณบุรี สมุทรสาคร



เขต 4 สระบุรี
สระบุรี ลพบุรี
นครนายก ปทุมธานี



เขต 3 นครสวรรค์
นครสวรรค์ กำแพงเพชร
ชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี



ข้อเสนอแนะ



ด้านการพัฒนาระบบบริการ

ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)

และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS)

ปี 2565



ที่มา

การผ่าตัดมีแนวโน้มมากขึ้น พบปัญหาอุปสรรคในด้านการบริการ ได้แก่ ระยะเวลารอการผ่าตัดนาน การนัดหมายคิว การรอวันมานอนโรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวผ่าตัด การนอนพักฟื้นสังเกตอาการ รวมถึงการจัดการความเจ็บปวดจากการผ่าตัด ทำให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการรับการรักษาเป็นระยะเวลานาน ท้ายที่สุดทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยเข้าถึงการบริการที่จำเป็นได้น้อยลง

ประโยชน์

ข้อมูลในปีงบประมาณ 2561-2564 พบว่าการทำหัตถการ **ODS** จำนวน 41,532 รายนั้น สามารถลด ค่าใช้จ่ายภาคประชาชน ได้จำนวน 66,451,200 บาท [ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้ป่วย: ค่าอาหาร 200 บาท/ค่าเดินทาง 200 บาท/ค่าเสียเวลา 400 บาท (รวม 800 บาท/คน/วัน)] ลดวันนอนโรงพยาบาลได้ 83,064วัน (41,532 ราย * 2วัน) จึงเห็นได้ว่าการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายรวมทั้งการสูญเสียรายได้ของประชาชน ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งของผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน และปลอดภัย ลดระยะเวลารอคอยการรักษา ลดความแออัดในโรงพยาบาล ทำให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินหรือโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

One day surgery and 2P Safety

การผ่าตัดวันเดียวกลับ **One Day Surgery (ODS)** คือ การรับผู้ป่วยเข้ามาเพื่อรับการรักษาด้วยการผ่าตัด (**surgery**) หรือหัตถการ (**medical intervention**) ที่ได้มีการเตรียมการไว้ก่อนแล้ว และให้ผู้ป่วยกลับบ้านในวันเดียวกันกับวันที่เข้ารับการรักษาหรืออยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ชั่วโมง และไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งการผ่าตัดแบบ **One Day Surgery (ODS)** เป็นการผ่าตัดที่ต้องมีการคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมและมีแนวทางปฏิบัติในการให้บริการพยาบาล ทั้ง ก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด หลังผ่าตัด และการติดตามหลังการผ่าตัดที่มีแนวทางเฉพาะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทุกขั้นตอนของการผ่าตัด โดยนำหลักการของ **2P (Patient & Personnel) Safety** มาออกแบบการให้บริการเพื่อให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากร ดังนี้

One day surgery and 2P Safety (ต่อ)

- **Surgical Safety Checklist**

คือ เครื่องมือสำหรับช่วยตรวจสอบและประเมินความพร้อมโดยมีการสื่อสารในทีมให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัย แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือก่อนให้ยาระงับความรู้สึก (**sign in**) ก่อนลงมีด (**time out**) และก่อนผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด (**sign out**) โดยใช้หลักการของ **Zero defect** คือ ดำเนินการตามมาตรฐานเป็นขั้นตอน มีการ**cross check** ถ้าไม่ทำขั้นตอนนี้จะไม่ยอมให้ทำขั้นตอนต่อไป มีการเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ผิดพลาดเพื่อปรับระบบแก้ไข โดยทุกขั้นตอนควรต้องดำเนินการด้วยแพทย์ผ่าตัด วิสัญญีแพทย์/พยาบาล และพยาบาลห้องผ่าตัด และควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอน **surgical safety checklist** และป้องกันอุบัติการณ์การผ่าตัด ผิดข้าง ผิดคน ผิดทิศทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่มาทำการผ่าตัด

- **Pitfall :** ในการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ควรมีการออกแบบขั้นตอนการ **Mark site** ที่ชัดเจน ต้องกำหนดว่าทำโดยใคร เช่น พยาบาลประจำศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ หรือแพทย์เจ้าของไข้ก่อนเข้าห้องผ่าตัด ซึ่งเป็นจุดสำคัญและเกิดข้อผิดพลาดบ่อยเนื่องจากผู้ป่วยเดินทางมาจากบ้านแล้วเข้าห้องผ่าตัดเลยในช่วงเช้า

One day surgery and 2P Safety (ต่อ)

- **Surgical Site Infection (SSI) prevention**

คือการป้องกันการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัด โดยแบ่งชนิดของการติดเชื้อเป็น **superficial incisional** คือการติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของแผลผ่าตัด ภายใน 30 วันหลังผ่าตัด ส่วน **deep incisional** คือการติดเชื้อลึกมาถึงพังพืด (**facia**) กล้ามเนื้อ (**muscle**) และการติดเชื้อในอวัยวะหรือ ช่องต่างๆของร่างกาย (**organ/space**) ภายใน 30 วัน หรือ 90 วันหลังผ่าตัดกรณีที่มีการใส่อุปกรณ์เทียม โดยต้องมีแนวทางปฏิบัติการป้องกันโดยการให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อและระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อหลังการผ่าตัด รวมถึง แนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ระบบการไหลเวียนอากาศในห้องผ่าตัด

- **Pitfall:** ในการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ควรมีการออกแบบขั้นตอนในการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อก่อนการผ่าตัดตามหัตถการที่ทำการผ่าตัดอย่างชัดเจน รวมทั้งติดตามหลังผ่าตัดโดยทีมพยาบาลโดยมีคำถาม หรือการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดเชิงรุกหลังการผ่าตัดที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง และอาจมีการติดตามโดยใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยเช่นการถ่ายภาพแผลผ่าตัดช่วยในการติดตามเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับผู้ป่วยในการติดตาม และต้องมีการทบทวนเมื่อมีอุบัติการณ์การติดเชื้อหลังการผ่าตัดเพื่อปรับปรุงระบบและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

One day surgery and 2P Safety (ต่อ)

- **Safe Anesthesia**

คือความปลอดภัยในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย หมายถึง อัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกี่ยวข้องกับการให้ยาระงับความรู้สึกในอัตราต่ำ และหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจป้องกันได้ โดยมีกระบวนการทำงานตามขั้นตอนในการระงับความรู้สึกโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในขั้นตอนต่างๆ ก่อนทำการระงับความรู้สึก (**pre-anesthetic evaluation**) ระหว่างการระงับความรู้สึก หลังการระงับความรู้สึก และการดูแลผู้ป่วยหลังการระงับความรู้สึกในห้องฟื้นคืน (**post-anesthetic care**)

- **Pitfall:** ในการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ให้ความสำคัญในเรื่องของ **pre-anesthetic evaluation** ก่อนทำการผ่าตัดต้องได้รับการประเมินการให้ยาระงับความรู้สึกก่อนการผ่าตัด เพื่อประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ลดการงดเลื่อนผ่าตัด และควรมีแนวทางในการจำหน่ายผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเช่นใช้ **scoring** ที่เหมาะสม ตามแนวทางของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย



One day surgery and 2P Safety (ต่อ)

- **Safe Operating Room**

คือ สิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดที่เป็นผลจากนโยบายและการปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัย ไม่เกิดอันตราย ต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เช่น พื้นที่การทำงานห้องผ่าตัด ระบบระบายอากาศ มีการกรองอากาศ และการหมุนเวียนอากาศในห้องผ่าตัด **20 air change per hour (ACH)** ระบบไฟ **pipeline system** อุณหภูมิที่ **22-24 °C** เป็นต้น

- **Pitfall:** ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน และมีการทวนสอบด้วยหน่วยงานวิศวกรรมทางการแพทย์ตามช่วงเวลาที่กำหนด



One day surgery and 2P Safety (ต่อ)

- **Acute Pain Management**

คือ การจัดการความปวดเฉียบพลัน เป็นความปวดที่มีระยะปวดไม่เกิน 3 เดือน มักเป็นความปวดที่มีกลไกการเกิดชนิดที่มีการกระตุ้นตัวรับความปวด (**nociceptive pain**) ร่วมกับการอักเสบ มีส่วนน้อยที่เป็นความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทอย่างเฉียบพลัน (**acute neuropathic pain**)

- **Pitfall:** ในการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ โรงพยาบาลต้องมีแนวทางการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัดโดยใช้หลักของ **multimodal analgesia** และ **preventive analgesia** ตามชนิดของหัตถการและการผ่าตัด (**procedure-specific pain management**) ร่วมเป็นแนวทางการรักษาในการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

One day surgery and 2P Safety (ต่อ)



- **Security and Privacy of Information and social media**

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (**Information Security**) คือ การคุ้มครองป้องกันข้อมูลและระบบสารสนเทศของบุคคลหรือองค์กร จากการถูกเข้าถึง ใช้เปิดเผย แก้ไข ทำลายหรือระงับการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความเป็นส่วนตัว (**Privacy**) คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การเข้าถึงใช้และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว เป็นไปตามความประสงค์และความยินยอมของผู้นั้น ยกเว้นกรณีปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล (**Personal Information**) คือ ข้อมูลของบุคคลหรือเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ หรือเข้าใจได้ว่าหมายถึงข้อมูลของบุคคลใด ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลต้องให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศของผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้รับการคุ้มครอง ต้องมีการกำหนดผู้ที่เข้าถึงข้อมูล

กระบวนการขอความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว (**Informed Consent**)
ในส่วนของการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลเพื่อการรักษา ติดตามอย่างชัดเจน



One day surgery and 2P Safety (ต่อ)

- **Pitfall** : ในการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและผ่าตัดแผลเล็ก ต้องมีการตรวจติดตามหลังการผ่าตัด อาจมีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดตามผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น **line** ซึ่งต้องมีการวางระบบความปลอดภัยที่ชัดเจน กำหนดผู้คนที่เข้าถึงข้อมูล รูปภาพ ในการใช้ติดตาม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ป่วย และบุคลากรที่ให้บริการ และรองรับกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลใน อนาคต

ข้อเสนอแนะ

ด้านการพัฒนาระบบบริการ

ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก

(ODS&MIS) ปี 2566



สรุป กลุ่มโรค/หัตถการ ODS ปี2566



เอกสารหมายเลข ๑.๑ แผนท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน
และกรณีการบริการผ่าตัดผ่านกล้อง พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มโรค กลุ่มอาการ หรือหัตถการ และข้อบ่งชี้กรณีการบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน (One Day Surgery)
มีดังนี้

๑. โรคไส้เลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia)
๒. โรคถุงน้ำอัณฑะ (Hydrocele)
๓. โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)
๔. ภาวะเลือดออกผิดปกติจากมดลูก (abnormal uterine bleeding)
๕. หลอดเลือดดำในหลอดอาหาร และกระเพาะอาหารโป่งพอง (Esophageal varices, Gastric varices)
๖. ภาวะหลอดอาหารตีบ (Esophageal stricture)
๗. มะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามที่อุดตัน (Obstructive esophageal cancer/tumor)
๘. ตุ่มเนื้องอกลำไส้ใหญ่ (Colorectal polyp)
๙. นิ่วในท่อน้ำดี (Bile duct stone)
๑๐. นิ่วในท่อน้ำตับอ่อน (Pancreatic duct stone)
๑๑. ภาวะท่อน้ำดีตีบ (Bile duct stricture)
๑๒. ภาวะท่อน้ำตับอ่อนตีบ (Pancreatic duct stricture)
๑๓. สิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหารส่วนต้น (Foreign body of upper Gastrointestinal Tract)
๑๔. การผ่าตัดตัดเนื้อ (Pterygium Excision with graft)
๑๕. การทำหมันหญิง (Female sterilization)
๑๖. การจัดการกระดูกหักให้เข้าที่ โดยการผ่าตัดผ่านผิวหนังด้วยแผลขนาดเล็ก (Percutaneous fracture fixation)
๑๗. ซีสต์พสุตร (Fistula in ano)
๑๘. พิรอบไส้ตรง ทวารหนัก (Perirectal, Perianal abscess)
๑๙. ซีสต์เต้านม (Breast abscess)
๒๐. นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Vesicle stone)
๒๑. นิ่วในท่อไต (Ureteric stone)
๒๒. นิ่วในท่อปัสสาวะ (Urethral stone)
๒๓. ท่อปัสสาวะตีบ (Urethral stricture)
๒๔. แผลถลอก หรือแผลปริร้าวขอบทวาร (Anal fissure)
๒๕. ความผิดปกติของอัณฑะที่ได้รับการตัดลูกอัณฑะ (Orchidectomy)

สรุป กลุ่มโรค/หัตถการ ODS ปี 2566

๒๖. การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก และการผ่าตัด (Hysteroscopy) เพื่อรักษาความผิดปกติของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน

๒๗. การตัดนิ้วมือ (Amputation Finger)

๒๘. การผ่าตัดก้อนโรคที่เต้านม (Wide Excision Breast mass)

๒๙. ความผิดปกติของเต้านมที่รักษาด้วยการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด (Simple Mastectomy)

๓๐. การรักษาเนื้องอกเต้านมโดยการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม (Breast Conservative Surgery)

๓๑. การลิ้นติด (Tongue tie Release)

๓๒. การตัดนิ้วเท้าในแผลเบาหวานและเนื้อตายที่เท้า (Diabetic foot With gangrene)

๓๓. การปลูกถ่ายผิวหนังใน Granulation Wound

๓๔. การผ่าตัดเส้นเลือดขอด (Varicose vein)

๓๕. การลิ้นติดหรือหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย (Phimosis, Paraphimosis)

๓๖. การผ่าตัดนิ้วและการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ (Obstructive uropathy)

๓๗. การผ่าตัดเส้นเลือดคอตีบบริเวณถุงอัณฑะ (Varicocele)

๓๘. การผ่าตัดปะแก้วหูเพื่อรักษาหูชั้นกลาง (Chronic otitis media, Perforated tympanic membrane, atelectatic otitis media, adhesive otitis media)

๓๙. การผ่าตัดเพื่อรักษาเนื้องอกที่กล่องเสียง (Laryngotracheal stenosis, tumor/cyst at larynx hypopharynx base of tongue)

๔๐. การผ่าตัดเพื่อการรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง (Hypertrophy of turbinate)

๔๑. การผ่าตัดรักษาโรคเกี่ยวกับต่อมบาร์โธลิน (Cyst/abscess of Bartholin's gland) (ถุงน้ำบาร์โธลินหรือถุงหนองต่อมบาร์โธลิน)

๔๒. การตัดตึงเนื้อหรือเนื้องอกในโพรงมดลูก (Submucous myoma uteri, polyp of corpus uteri) (เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกในโพรงมดลูก และตึงเนื้อเยื่อโพรงมดลูก)

๔๓. การส่องกล้องใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy : PEG)

๔๔. การส่องกล้องใช้เข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อบริเวณตับอ่อนนำทางด้วยกล้องคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS-FNB [endoscopic ultrasound-guided fine needle biopsy] pancreas)

๔๕. การส่องกล้องใช้เข็มเจาะดูดชิ้นเนื้อบริเวณตับนำทางด้วยกล้องคลื่นเสียงความถี่สูง (EUS-FNB [endoscopic ultrasound-guided fine needle biopsy] liver)

๔๖. การฉีดสารฟิลเลอร์ที่เส้นเสียง (Injection laryngoplasty)

๔๗. การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาพยาธิสภาพที่กล่องเสียง (Endoscopic laryngeal surgery)

๔๘. การผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู (Tympanoplasty)

๔๙. การวางสายเพื่อการล้างไตในช่องท้อง (Tenckhoff catheter)

๕๐. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ในกลุ่มความเสี่ยงสูง

สรุป กลุ่มโรค/หัตถการ ODS ปี2566



- ๕๓. การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (Loop Electrosurgical Excision procedure)
- ๕๔. การผ่าตัดโรคจอตาและวุ้นตา (Vitreoretinal surgery)
- ๕๕. การผ่าตัดเพื่อเปิดทางระบายน้ำจากช่องหน้าลูกตาไปได้เมื่อรูตา (Trabeculectomy)
- ๕๖. การผ่าตัดเพื่อใส่ท่อระบายน้ำจากช่องหน้าลูกตาไปได้เมื่อรูตา (Tube shunt surgery)
- ๕๗. การผ่าตัดเบ้าตา (Orbital surgery)
- ๕๘. การผ่าตัดเปลือกตา (Eyelid surgery) เพื่อการรักษาเท่านั้น
- ๕๙. การผ่าตัดระบบน้ำตา (Lacrimal surgery)
- ๕๑. การผ่าตัดแก้มหนังตาหย่อน (Rhytidectomy/Blepharoplasty) เฉพาะกรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

เพื่อการรักษา

๕๒. การผ่าตัดโดยวิธีการฉายแสงเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระจกตา (Corneal Collagen Cross Linking)

๖๐. การยิงเลเซอร์ทำลายซีสต์อีวรินอติ (Cyclophotocoagulation)

๖๑. การผ่าตัดทำลายเยื่อตาและผ่าตัดตัดแต่งเยื่อตา (Excision or destruction of lesion or tissue of conjunctiva)

๖๒. โรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ (Symptomatic gallstone/Cholecystitis)

๖๓. การผ่าตัดก้อนน้ำเหลืองเซนติเนล (Sentinel lymph node biopsy: SLNB)

๖๔. การผ่าตัดก้อนน้ำเหลืองที่รักแร้ออกทั้งหมด (Axillary lymph node dissection: ALND2)

๖๕. การตรวจวินิจฉัยช่องท้องโดยการส่องกล้อง ร่วมกับการตัดชิ้นเนื้อ และหรือการเก็บน้ำในช่องท้องส่งตรวจ (Diagnostic laparoscopy with peritoneal lavage for cytology and /or with biopsy)

๖๖. Vascular access for hemodialysis ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

๖๗. บริการ Appendectomy: ให้ Platform ODS แต่เพื่อความปลอดภัยเพิ่มการติดตามดูแลต่อเนื่องแบบ Home ward โดยจ่ายแบบบริการ Home Ward ตั้งแต่ผ่าตัดต่อเนื่องไปจนถึงการดูแลที่บ้าน

สรุป กลุ่มโรค/หัตถการ MIS ปี2566

เอกสารหมายเลข ๒.๑ แนวท่ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการบริการผ่าตัดแบบไม่ค้างคืน
และกรณีการบริการผ่าตัดผ่านกล้อง พ.ศ. ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มโรค กลุ่มอาการ หรือหัตถการ และมีกรให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimally Invasive Surgery (MIS) ดังนี้

๑. โรคนิ่วในถุงน้ำดีและหรือถุงน้ำดีอักเสบ (Symptomatic gallstone/ Cholecystitis)
๒. โรคเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกและรังไข่ (Myoma uteri and Ovarian tumor)
๓. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer)
๔. ภาวะเนื้องอก ภาวะเลือดออก และภาวะติดเชื้อในช่องอก (Tumor, Hemothorax and Emphysema thoracis)
๕. ภาวะเอ็นไขว้หน้าขาดและการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูก (ACL & Meniscal injury)
๖. โรคน้ำและเนื้องอกที่รังไข่ การบิดของรังไข่หรือเนื้องอกที่รังไข่ โรคเยื่อโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่รังไข่ (Benign neoplasm of ovary, torsion of ovary, endometriosis of ovary)
๗. โรคไส้เลื่อนขาหนีบที่เป็นสองข้าง และโรคไส้เลื่อนขาหนีบที่กลับเป็นซ้ำ (Bilateral inguinal hernia, recurrence inguinal hernia)
๘. ภาวะอ้วนที่เป็นโรค หรือโรคอ้วนทุพพลภาพ (Morbid obesity)
๙. การผ่าตัดไตผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic Nephrectomy)
๑๐. การส่องกล้องระบายน้ำดีสู่ระบบทางเดินอาหารด้วยกล้องส่องอัลตราซาวด์ (Endoscopic ultrasound guided biliary drainage)
๑๑. การผ่าตัดผ่านกล้องการวินิจฉัยและตัดชิ้นเนื้อในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ หรือมะเร็งทางนรีเวช (Laparoscopic diagnosis and biopsy in CA ovary, CA peritoneum)
๑๒. การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic sinus surgery using microdebrider)
๑๓. การผ่าตัดต่อมหมวกไตผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic Adrenalectomy)
๑๔. การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic Appendectomy) (เฉพาะในผู้ป่วย BMI > ๓๕ และ Uncertain Dx. In Female)
๑๕. การผ่าตัดลำไส้ตรงผ่านกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic low anterior resection) หรือการผ่าตัดลำไส้ตรงและทวารหนักออกผ่านกล้องทางหน้าท้อง [Laparoscopic abdomino-perineal resection (APR)] สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ (Colorectal CA)
๑๖. การผ่าตัดส่องกล้องเย็บซ่อมเอ็นหมุนไหล่และตัดกระดูก (Arthroscopic rotator cuff surgery and acromioplasty)

สรุป กลุ่มโรค/หัตถการ MIS ปี2566

- ๑๗. การผ่าตัดส่องกล้องเย็บซ่อมเยื่อหุ้มข้อไหล่และหมอนรองเบ้าข้อไหล่ (Arthroscopic Bankart surgery and labral repair)
- ๑๘. การผ่าตัดมดลูกแบบกว้างหรือผ่าตัดแบบถอดรากโคน (radical hysterectomy)
- ๑๙. Laparoscopic Prostatectomy and Robotic prostatectomy (อยู่ระหว่างการกำหนดค่า K)



การจัดการการพยาบาลผู้ป่วย ODS & MIS

รศ.ดร.อุษาวดี อัครวิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

การจัดการการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดวันเดียวกลับ (**Nursing Case Management for One Day Surgery: ODS/Minimally Invasive Surgery: MIS**) หมายถึง การจัดการการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการรักษา ทำหัตถการ หรือ ผ่าตัดที่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว และสามารถให้กลับบ้านในวันเดียวกันกับวันที่รับไว้ ทำหัตถการ หรือ ผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง ถึงเวลาจำหน่ายออกไม่เกิน 24 ชั่วโมง ตามรายการหัตถการ

การผ่าตัดแผลเล็ก (**Minimally Invasive Surgery**) หรือเรียกว่า การผ่าตัดผ่านกล้อง หรือเป็นการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายน้อยกว่าการรักษาในรูปแบบเดิม เป็นการผ่าตัดเพื่อทำการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย โดยบาดแผลที่เกิดจากการผ่าตัดนั้นจะมีขนาดเล็ก (อาจมีมากกว่า 1 แผล) ลดอาการเจ็บแผล และใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด

การจัดการการพยาบาลผู้ป่วย ODS & MIS



รศ.ดร.อุษาวดี อัครวิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ
(ต่อ)

1. ระยะก่อนผ่าตัด

- การเตรียมผู้ป่วยและญาติ: ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่บ้าน เช่น งดอาหารและน้ำตามที่แพทย์กำหนด หรือการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหลังผ่าตัด เป็นต้น
- การตรวจประเมิน: ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพบวิสัญญีแพทย์ เพื่อประเมินว่าเหมาะสมกับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับหรือไม่
- การให้ความรู้: สอนเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังผ่าตัด วิธีการปฏิบัติตัว การรับประทานยา การสังเกตอาการผิดปกติ และการติดต่อโรงพยาบาลเมื่อมีปัญหา

2. ระยะในโรงพยาบาล (ระหว่างพักฟื้นหลังผ่าตัด)

- การประเมินหลังผ่าตัด: พยาบาลจะดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดหลังการผ่าตัด ประเมินระดับความปวด การตอบสนองต่อการรักษา และการเคลื่อนไหว
- การจัดการความปวด: จัดการความปวดด้วยยาตามคำสั่งแพทย์
- การดูแลแผล: ดูแลแผลผ่าตัดให้สะอาด ป้องกันการติดเชื้อ

การจัดการการพยาบาลผู้ป่วย ODS & MIS



รศ.ดร.อุษาวดี อัครวิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ คณะพยาบาลศาสตร์ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ
(ต่อ)

3. ระยะหลังจำหน่ายกลับบ้าน

- การติดตามผล: โรงพยาบาลอาจมีการติดตามผลการรักษาผ่านระบบ **Telehealth** หรือนัดมาตรวจติดตามที่โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด
- การดูแลต่อเนื่อง: เน้นย้ำให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างราบรื่น

ศิริราช บทบาทของพยาบาลผู้ประสานงาน

พยาบาลหน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์

1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ให้คำแนะนำการให้ความรู้ เกี่ยวกับโรค การผ่าตัด การเตรียมความพร้อมก่อน และหลังผ่าตัด แก่ผู้ป่วยและญาติ เมื่อแพทย์แนะนำให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
2. ประเมินภาวะสุขภาพ ความเสี่ยง วิเคราะห์ปัญหา ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
3. ประเมินความพร้อมของญาติหรือผู้ดูแล
4. ประสานงานกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยวิสัญญีวิทยา
5. การโทรติดต่อผู้ป่วย 7-10 วันก่อนผ่าตัด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสิทธิการรักษา การงดยาละลายลิ่มเลือด หรือยาบางตัวที่ต้องงดก่อนผ่าตัดตามแพทย์สั่ง หรือการรับประทานยาบางตัว เช่น ยาระบายตามแพทย์สั่ง
6. การโทรติดต่อผู้ป่วย 1-3 วันก่อนผ่าตัด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด



ศิริราช บทบาทของพยาบาลผู้ประสานงาน

พยาบาลหน่วยตรวจโรคัลลยศาสตร์ (ต่อ)

7. การโทรติดตามอาการผู้ป่วย หลังผ่าตัด **post op day 0** ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติในการดูแลภายหลังผ่าตัด เป็นที่ปรึกษาเมื่อผู้ป่วยและญาติมีข้อสงสัยหรือวิตกกังวล เพื่อคลายความกังวล และมีความมั่นใจในการดูแลที่บ้าน
8. การโทรติดตามอาการผู้ป่วย หลังผ่าตัด **post op day 1**
9. การโทรติดตามอาการผู้ป่วย หลังผ่าตัด **post op day 2**
10. ลงระบบ **registry** ผู้ป่วย
11. การเขียนบันทึกทางการพยาบาล

ศิริราช บทบาทของพยาบาลWR



1. ชักประวัติผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัดและลงบันทึกในใบ Perioperative Nursing Record

- การงดน้ำและอาหารก่อนมาผ่าตัด
- โรคประจำตัว ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
- ประวัติการผ่าตัดและการได้รับยาระงับความรู้สึก
- ประวัติการแพ้ยา/อาหาร การใช้ยาสมุนไพร/วิตามินต่างๆ การใช้ยาประจำ เช่น ยา anticoagulant เป็นต้น
- ประวัติการสูบบุหรี่/ดื่มสุรา
- ปัจจัยทางด้านจิตใจ เช่น ความกลัว วิดกกังวล เป็นต้น
- ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น อาชีพ ผู้ดูแล เป็นต้น

ศิริราช บทบาทของพยาบาลWR (ต่อ)



2. ตรวจสอบเอกสารสำคัญในการทำผ่าตัด

- หนังสือแสดงเจตนาขอรับการตรวจรักษาโดยวิธีการผ่าตัดหรือหัตถการ และการระงับความรู้สึก
- แบบบันทึกการตรวจสอบการระบุตัวผู้ป่วย อวัยวะ ตำแหน่ง/ข้างที่ทำ ผ่าตัดหรือหัตถการ
- คำสั่งการรักษาของแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัดครั้งนี้ (ในระบบ SiIT Enterprise)

3. ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการผ่าตัด

- การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเฉพาะโรค
- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระงับความรู้สึก



ศิริราช บทบาทของพยาบาลOR

- รับข้อมูลผู้ป่วยจากพยาบาล **WR**
- การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ
- ประเมิน/ เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
- เตรียมอุปกรณ์/หรือช่วยแพทย์ในการจัดทำผู้ป่วย
- เตรียมเครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด
- การระบุตัวผู้ป่วยและตำแหน่งผ่าตัด
- ร่วมเป็นบุคลากรในทีมผ่าตัด
- มีส่วนร่วมในการทำ **Sign in Briefing** ทีมใหญ่ **Time out** และ **Sign out**
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- ทำแบบบันทึกทางการพยาบาล **Perioperative Nursing Record**
- ส่งต่อข้อมูลและรายงานปัญหาของผู้ป่วยให้ **RR**

ศิริราช บทบาทของพยาบาลRR



1. การประเมินผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ

- การลงบันทึกในใบ **Perioperative Nursing Record**

2. การบริหารความปวด (**Pain Management**)

- การประเมินระดับความปวด และให้ยาบรรเทาปวด
- การลงบันทึกการให้ยาตาม **Focus Charting**
- การบันทึกและติดตามอาการหลังการให้ยา

3. การจำหน่ายผู้ป่วยออกจากห้องพักรักษา

- การให้คะแนนผู้ป่วยในห้องพักรักษาว่าถึงเกณฑ์ให้ออกจากห้องพักรักษา

(**Discharge criteria**)

- การให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและการดูแลแผลเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน
- อาการผิดปกติที่ต้องติดต่อพบแพทย์ก่อนนัด
- การมาพบแพทย์ตามนัดหมาย การตรวจติดตามต่อ ตามแผนการรักษา
- การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเอง

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการการพยาบาล
สำหรับการ ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก

Program of Nursing Specialty in Nursing Case Management for
One Day Surgery (ODS) /Minimally Invasive Surgery (MIS) ภาค
วิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

รุ่นที่3 เปิดรับสมัคร 26 มิถุนายน 2569 – 31 ตุลาคม 2569

อบรมระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2570 – 23 เมษายน 2570



ผู้ผ่านการอบรม

มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการ
ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการตรวจพิเศษด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการ
ดูแลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน และ
มีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการผ่าตัด หรือได้รับการทำหัตถการ
พร้อมทั้งระบบติดตามที่บ้าน อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
คำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม ประสานงาน ปฏิบัติงาน
ร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย

- 1 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยการเคารพในเอกสิทธิ์ของผู้ป่วย (Autonomy)
- 2 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- 3 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
- 4 สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
- 5 ดูแลผู้ป่วยโดยคำนึงถึงความเชื่อ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
- 6 สามารถให้การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
- 7 ปฏิบัติการพยาบาลภายใต้กฎหมายวิชาชีพ
- 8 สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นจริยธรรม บนพื้นฐานจรรยาบรรณ วิชาชีพ หลักจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพได้เหมาะสม

สมรรถนะด้านปฏิบัติการพยาบาล

- 1 สามารถประเมินผู้ป่วย/ ครอบครัว ได้ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคมและจิตวิญญาณ
- 2 สามารถจัดการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยได้สอดคล้องกับสถานะผู้ป่วย และครอบคลุมในทุกระยะของการผ่าตัด
- 3 สามารถนำแผนการพยาบาลไปสู่การปฏิบัติและปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์
- 4 สามารถจัดระบบปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว ที่มารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก ได้อย่างครอบคลุมทุกระยะของการผ่าตัด รวมทั้งการดูแลต่อเนื่องภายหลังจำหน่าย
- 5 สามารถจัดระบบการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก ให้ได้รับความปลอดภัย

สมรรถนะด้านปฏิบัติการพยาบาล (ต่อ)

- 6 สามารถบริหารจัดการทางการพยาบาล ในการใช้ จัดเตรียมเครื่องมือ และบริหารเครื่องมือผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7 สามารถจัดการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 8 สามารถทำบทบาทของผู้จัดการทางการพยาบาล (Nurse Manager) สำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก
- 9 สามารถบริหารยาอย่างสมเหตุผล เช่น ยาในกลุ่มปฏิชีวนะ ยาละลายลิ่มเลือด ยากลุ่ม high alert drug
- 10 สามารถจัดการทางการพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการผ่าตัดแผลเล็ก อย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งการสื่อสารและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว

สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ

- 1 มีการพัฒนาความรู้เชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- 2 มีการแสดงออกในการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณในสถานการณ์ต่าง ๆ
- 3 ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติและนโยบายของหน่วยงาน
- 4 มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
- 5 มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ
- 6 มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก

สมรรถนะด้านภาวะผู้นำ การจัดการ และพัฒนาคุณภาพ

- 1 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ทางการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการ
ผ่าตัดแผลเล็ก
- 2 สามารถทำงานร่วมกับทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- 3 สามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม คุ่มค่า คุ่มทุน

สมรรถนะด้านวิชาการและวิจัยคุณภาพการพยาบาล

- 1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
- 2 สามารถนำหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือผลการวิจัย มาใช้ในการปฏิบัติงาน
- 3 สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน กับผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้อง
- 4 สามารถสืบค้นความรู้ และสรุปประเด็นเพื่อนำมาถ่ายทอดได้

สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ

- 1 สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว และทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2 สามารถประสานงานกับทีมสุขภาพ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
- 3 สามารถนำเสนอ/เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนผลงาน ในระดับหน่วยงาน/องค์กร

สมรรถนะด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ

- 1 สามารถใช้เทคโนโลยีในการบันทึก และรายงานข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2 สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางคลินิกเพื่อการติดตามผู้ป่วย ระวัง การจัดการความเสี่ยง และพัฒนาคุณภาพบริการ
- 3 สามารถสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสารสนเทศจากช่องทาง ต่าง ๆ
- 4 สามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง

สมรรถนะด้านสังคม

- 1 สามารถสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
- 2 สามารถใช้ความรู้เฉพาะทางการพยาบาล เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
- 3 ติดตามข้อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐกิจ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อมาประยุกต์ใช้

The End

